

PSICOSIS

Guía de información para pacientes y familiares

¿QUÉ ES LA PSICOSIS?

La psicosis no es una enfermedad única, sino un síndrome que puede aparecer en diferentes trastornos. Se caracteriza por una alteración en la percepción de la realidad: la persona experimenta cosas que otros no perciben o sostiene creencias que no se corresponden con la realidad.

- La psicosis es tratable — la mayoría de las personas mejoran significativamente.
- No es una debilidad de carácter ni es culpa de la persona.
- La intervención temprana mejora el pronóstico.
- El diagnóstico no define quién es usted como persona.

SÍNTOMAS

SÍNTOMAS POSITIVOS (se añaden)	SÍNTOMAS NEGATIVOS (disminuyen)	SÍNTOMAS COGNITIVOS
Alucinaciones (escuchar voces, ver cosas), delirios (creencias falsas fijas), pensamiento desorganizado.	Apatía, falta de motivación, reducción de la expresión emocional, aislamiento social.	Dificultades de concentración y memoria. Problemas para planificar y tomar decisiones.

TRATAMIENTO

La psicosis se trata con medicación antipsicótica y apoyo psicosocial. La combinación de ambos ofrece los mejores resultados. El tratamiento precoz mejora significativamente el pronóstico.

Medicación antipsicótica

- Es el tratamiento farmacológico fundamental para la psicosis.
- Reduce los síntomas positivos (alucinaciones, delirios) y previene recaídas.
- Puede tardar varias semanas en hacer efecto completo — es importante mantenerla.
- Si un fármaco no funciona o produce efectos secundarios molestos, existen alternativas.
- No suspenda la medicación sin consultar a su médico, aunque se sienta bien.
- Existen presentaciones inyectables de acción prolongada para quienes tienen dificultad con las pastillas diarias.

Apoyo psicosocial

- La psicoterapia y las intervenciones de apoyo complementan la medicación.
- La participación de la familia en el tratamiento es uno de los factores más importantes para la recuperación.
- Mantener una rutina, el ejercicio regular y el contacto social mejoran la calidad de vida.

SEÑALES DE ALERTA DE RECAÍDA

Reconocerlas a tiempo permite actuar antes de una crisis. Suelen aparecer días o semanas antes de una recaída completa.

Señales frecuentes	Qué hacer
• Alteraciones del sueño • Aumento de la ansiedad o irritabilidad • Mayor desconfianza o suspicacia • Aislamiento social • Descuido del autocuidado • Reparición de voces o pensamientos inusuales • Abandono de la medicación	• Contacte a su equipo de salud mental lo antes posible. • Asegúrese de estar tomando la medicación correctamente. • Hable con un familiar o persona de confianza. • Reduzca el estrés y descance lo suficiente. • Evite el alcohol y las drogas.

ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO

Para mantenerse bien	Lo que empeora los síntomas
• Tome la medicación según lo prescrito, incluso cuando se sienta bien. • Mantenga un horario regular de sueño. • Asista a todas sus citas de seguimiento. • Mantenga contacto con personas de apoyo. • Realice actividad física regular.	• El alcohol y las drogas empeoran los síntomas y aumentan el riesgo de recaída. • El estrés elevado y el aislamiento social. • El abandono de la medicación.

Para familiares y cuidadores

- Infórmese sobre la enfermedad — entender los síntomas ayuda a responder mejor.
- Aprenda a reconocer las señales de alerta de recaída.
- Mantenga una comunicación calmada y respetuosa — evite la crítica excesiva.
- Fomente la autonomía — la sobreprotección puede limitar la recuperación.
- Cuide también su propio bienestar. El cuidado de un familiar con psicosis puede ser agotador.



Busque ayuda urgente si:

- Aparecen pensamientos de hacerse daño o de suicidarse.
- Hay pensamientos de hacer daño a otras personas.
- Se produce un empeoramiento severo y brusco de los síntomas.
- La persona no puede cuidar de sí misma.

Línea de Atención a la Conducta Suicida (Ministerio de Sanidad)	024
Urgencias / Psiquiatría de guardia (cualquier hospital público)	112